

ANAMNESE DIRIGEE

L'anamnèse dirigée se fait à chaque entrée d'un patient aux soins aigus !

Anamnèse actuelle :

- Localisation, irradiation
- Qualité (colique, serrement, brûlure)
- Échelle de 0-10 (réveil nocturne ?)
- Chronologie (début, fin, durée, fréquence)
- Conditions de survenue
- Facteurs aggravants et soulageant
- Manifestions associées (nausées, vomissements, fièvre)

Anamnèse par système :

- Etat général (poids, sudations nocturnes, fièvre, fatigue)
- Céphalées, vertiges (*acouphènes*), malaises, pertes de connaissance
- Dyspnée (*après combien d'étages*), arythmie, palpitation, syncope, orthopnée, nycturie
- Toux (expectorations, hémoptysie)
- Transit (*sang dans les selles*), appétit, nausées, vomissements (*hématémèse*)
- Brûlures mictionnelles, hématurie, incontinence
- Éruption cutanée
- Douleurs musculaires, douleurs articulaires, rhumatisme

Anamnèse personnelle :

- Maladies actuelles (*diabète, hypertension, thyroïde, cholestérol, SAOS*)

Éventuellement demander s'il y a un suivi chez un spécialiste et date du dernier rdv

- Traitements habituels
- Antécédents chirurgicaux
- Allergies
- Vaccinations à jour
- Alcool, tabac
- Médicaments hors prescription, drogues
- Métier (*éventuellement situation à domicile*)
- Voyages récents

Anamnèse familiale :

- Maladies et cancers dans la famille
- Santé des parents (*ou cause de décès*)
- Santé des frères et sœurs
- Santé des enfants

Pour chaque patient, débiter le status par l'inspection générale (signes vitaux, perfusion des extrémités, conjonctive, cyanose, turgescence jugulaire, oedèmes)

Structure de l'Anamnèse

1. Anamnèse Actuelle/Motif de Consultation
2. Anamnèse par Système: Générale
3. TTT
4. Anamnèse Personnelle
5. Anamnèse Psychosociale/Professionnelle
6. Antécédents Personnels
7. Anamnèse Familiale
8. Présentation du patient
9. Anamnèse par Système

1) Anamnèse actuelle

Motif de consultation:

A) Plainte, Souffrance (patient atteint dans sa santé)

1. Localisation
2. Irradiation(= mvnt, diffusion)
3. Qualité (serrement, colique, brûlure, décharge électrique)
4. Intensité (0 à 10, douleur qui réveil la nuit?)
5. Chronologie (début, fin, durée, fréquence)
6. Condition de survenue
7. Facteurs le modifiant (aggravant ou soulageant)
8. Manifestations associées

B) Bilan de santé (patient peut être en bonne santé)

2) Anamnèse par Système: Générale

1. Etat général
2. Température (mesurée)
3. Poids + Taille ($BMI = \text{Poids} / [\text{taille}]^2$, évaluer perte, gain, cinétique)
4. Adénopathies
5. Sudations (nocturnes)
6. Allergies

3) TTT

1. Traitement Régulier
2. Traitements Occasionnels
3. « Substances annexes »
 - Vitamines
 - Plantes, etc...
4. Contraception

4) Anamnèse Personnelle

1. Etat général (ressenti par le patient)
2. Vaccinations
3. Risques liés à l'Environnement
4. Exercice et Loisirs
5. Habitudes alimentaires
6. Alcool, Tabac, Substances toxiques
7. Sexualité

5) Anamnèse

Psychosociale/Professionnelle

1. Situation sociale (état civil, vie de famille)
2. Vie au quotidien (déroulement de la journée)
3. Activité professionnelle
4. Parcours de vie/Expériences importantes
5. Croyances religieuses

6) Antécédents Personnels

1. Maladies et Traitements
2. Hospitalisations
3. Accidents et Blessures
4. Opérations
5. Examen Réalisé
6. Chronologie, Circonstances, Médecins, Hôpitaux

7) Anamnèse Familiale

1. Pathologies retrouvées dans la famille
2. Pathologies (+causes de †) des parents/gd-parents
3. Pathologies des frères et sœurs (à quel âge?)
4. Pathologies chez les enfants (à quel âge?)

8) Présentation du patient

1. Sexe, Nom, Age
2. Motif de consultation (1 SEUL !)
3. Antécédents, tabac, OH
4. Médicaments, Allergie
5. Anamnèse actuelle (centrée sur la plainte)
6. Anamnèse par système (éléments pertinents)
7. Status :
 - Constantes vitales (FC, Sat, FR, TA, T°)
 - Status ciblé sur plainte (éléments pertinents)
8. Examens complémentaires
 - ECG
 - Labo
 - Rx
 - ...
9. Liste des problèmes
10. Pour chaque problème, attitude

9) Cardiovasculaire

1. Douleurs thoraciques
2. Palpitations (brusque, chaleur poitrine, boule ds cou)
3. Dyspnée
 - Orthopnée (dyspnée couché)
 - Dyspnée paroxystique nocturne (~OAP)
4. Claudication - Douleurs des MI
5. Œdèmes des MI (soir+++, godet)
6. Varices
7. Ulcères (peau des MI, plaie chronique)
8. Pollakiurie nocturne
9. Cyanose (Centrale: langue, visage, extrémité; Doigts blanc/bleu, lésion)
10. Syncope (brusque: Malaise => perte conn. 2-3min, repos/post-réveil)

FRCVS (H>55ans, F>65ans, tabac, HTA, diabète, dyslipidémie, obésité, sédentarité, stress , ATCD CVD)]

9) Pulmonaire

1. Douleurs thoraciques (respiro-dép=plèvre; >toux=VAS)
2. Dyspnée
 - #1= ok
 - #2= exercice physique
 - #3= au moindre effort
 - #4= au repos
3. Toux (insp, exp, aigue<3sem, chronique>8sem)
4. Expectorations/Hémoptysie (volume, sang: massive: >200-600 ml/24h)
5. Asthme (facteurs déclenchants)
6. Ronflements
7. ARDS
 - 1) Cyanose
 - 2) Battement aile du nez
 - 3) Grunting
 - 4) Tirage
 - 5) Tachypnée

Tabac

9) Digestive

1. Douleurs abdominales (perforation, colique, inflammation;
douleur viscérale: organe vs somatique: péritoine)

Input (dernier repas, manger/boire)

2. Appétit - Poids
3. Dysphagie – Odynophagie_(douleur) (liquides, solides)
4. Nausées, vomissements
5. Pyrosis
6. Réplétion gastrique

Output

6. Dernier gaz
7. Selles (fréq, forme/couleur/odeur, sang, dernière Selle, incontinence)
8. Urinaires (fréquence, douleur, couleur)
9. Pertes vaginales, dernières règles?
6. Ictère
7. Symptômes associés (fièvre, poids, frissons, appétit, fatigue,
régurgitations, fonction intestinal, vertige)

9) Génito-Urinaire

1. Urines (fréquence, quantité, couleur, odeur)

- Pollakiurie (souvent) ||| Polyurie (beaucoup) ||| Nycturie (>1x/nuit)

2. Dysurie (difficultés: douleurs, brûlures)

- Algurie (douleur) ||| Hématurie (sang)

3. Douleurs loges rénales

4. Fonction sexuelle, libido, douleurs

5. ♂ : Ecoulement/Ulcération

6. ♀ : Règles (sans pilule, début, fin)

- Cycle 24-31j. / 3-7j.
- Dysménorrhée (douleurs pendant règles)
- Aménorrhée/ ménarche/ ménopause
- Polyménorrhée (règles + fréquentes)
- Métrorragie (sang entre 2 règles)
- Ménorragie (règles qui durent trop)
- Saignement post-coïtal

7. Pertes vaginales

8. Contraception et Test de Grossesse

9. Dépistage

9) Neurologie

1. Douleurs (décharge électrique, brûlure)
2. Céphalées
3. Vertiges
4. Epilepsie
5. Acuité visuelle, Auditive, Odorat, Goût, Toucher
6. Troubles de la sensibilité
7. Troubles moteurs
8. Troubles de l'équilibre
9. Troubles cognitifs (Mini Mental State)
 - Vigilance
 - Attention
 - Mémoire
 - Contenu de la pensée
 - Discernement
 - Langage
 - Humeur
 - Sommeil

9) Ostéo-Articulaire

1. Douleurs articulaires
2. Douleurs « osseuses »
3. Limitation fonctionnelle d'un membre
4. Œdème, rougeur articulaire
5. Perte de taille (> 4 cm)

9) Dermatologique

1. Eruption cutanée, Plaque rouge
2. Dyscoloration cutanée
3. « Boutons »
4. Lésions cutanées
5. Pilosité

9) Psychiatrique

1. Anxiété, Dépression
2. Comportements à risque (abus de substances)
3. Troubles du caractère
4. Éléments de la lignée psychotique
(fuite des idées, hallucinations, hypomanie)

Anamnèse Sexuelle

1. Mettre des mots sur les 4 phases physiologiques de la sexualité
(excitation, plateau, orgasme, résolution)
 2. Entretien approfondi (ouverture ou portes d'entrée, nommer le climat émotionnel, langage adapté, investigation ≠ inquisition)
 3. Trouble de la sexualité
 1. **anhédonie** (=pas de désir)
 1. svt après naissance chez femme ; homme fréquent si burnout
 2. **troubles de l'excitation** :
 1. Femmes : incidence augmente avec l'âge, fréquent chez femmes en ménopause
 2. Hommes : difficultés d'érections (ttt causal -> viagra)
 3. **troubles du plaisir** :
 1. Femmes : diverses origines (rapport au corps, besoin de contrôle, angoisses, conflits)
 2. Hommes : éjaculation précoce ou tardive
 4. **Anorgasmie** (addictions, pornographie)
- Dans le couple :
1. **Dyspareunie** (douleur lors des rapports sexuelles)
 2. **Vaginisme** (contraction musculaire prolongée ou récurrente des muscles du plancher pelvien (empêche toute pénétration désirée, ..) -> svt associé à des traumatismes)
 3. **aversion**
 4. **hypersexualité**

Anamnèse Alimentaire

1. État Général: 5AAAAA

1. Apathie (Pensée = Moral)
2. Asthénie (Forces = Activité)
3. Anorexie (Ingestas = appétit actuel / appétit en santé)
4. Amaigrissement (Poids = histoire du poids, BMI)
5. Apyrexie (Température)

2. Composition corporelle (masse musculaire/grasse)

3. Fonction Organes/Systèmes (att. fonction puis structure)

4. Balance énergétique (apports, pertes, besoins)

5. Métabolisme (calories, protéines)

Pédiatrie: PECIME

1. Motif de consultation
2. Signes de danger, de priorité: Tri
 - À l'hôpital
 - Au dispensaire
 - Au domicile
3. Principaux symptômes:
 - Enfant de 0- 2 mois
 - Toux
 - Diarrhée (Signes de gravité, Signes de déshydratation, Protocole normalisé du test du pli cutané)
 - Fièvre (durée (> 24 heures, > 7 jours), Eruption cutanée, Nuque raide douloureuse, Céphalées, Mictions douloureuses, Oreille, HIV, Zone de paludisme, Etat vaccinal)
 - Oreille et ORL
4. Etat NUTRITIONNEL
5. Etat VACCINAL
6. Histoire GROSSESSE
7. Courbes de croissance
8. Autres problèmes (chir par ex, situation familiale, psycho- sociale)
9. Type de suivi et organisation

Adolescent: HEADSSS

- **Home** (Habitation)
- **Education** (École)
- **Activities + Alimentation**
 - □Signes d'appel: Isolement, Changements fréquents d'amis
- **Drugs** (Drogues)
- **Santé Mentale: Sexuality + Safety + Suicide**
 - Santé Mentale: Fugues, Accidents, Violence
 - Sexualité: Contraception, Abus
 - Sécurité: conduite, médicaments, bagarre, police

Personnes âgées

- Anamnèse médicale traditionnelle
- Anamnèse fonctionnelle
 1. physique
 - activités de la vie quotidienne = AVQ
 - mobilité
 2. affectif
 3. cognitif
 4. sensoriel (vision, audition)
 5. nutritionnel
 6. socio-économique
 7. environnement
 - Familiale
 - architectural

URGENCE

- A. Airway + c-Spine protection
- B. Breathing + Oxygen
- C. Circulation + Hemorrhage control
- D. Disability / Neurologic status
- E. Exposure / Environment

1. Dissection aortique
 2. Infarctus du myocarde
 3. Péricardique constrictive = Tamponnade
 4. EP
 5. Pneumothorax
- # URGENCE

- Examen 1°: ABCDE
- Re-examen ABCDE + Examens Ciblés (Labo + RX)
- Évaluation 2°: Examen Complet + Examens Complémentaires (CT,"EEG,"etc...)

Attitude clinique

- 1) Préciser le motif de consultation
- 2) Transcrire en termes médicaux
- 3) Aigu/Chronique (aigu sur chronique)
- 4) DD: VIINDIMCATEM!; poser les bonnes questions
 - Vasculaire (AVC, anoxie)
 - Infectieux (encéphalite, sepsis)
 - Inflammatoire
 - Néoplasique (SNC, AB-Antineuronaux)
 - Dégénératif (démence)
 - Intoxication – Médicamenteux (OH, drogues, CO, EME)
 - Congénital
 - Autoimmun (vasculite, encéphalite)
 - Traumatique (TCC sévère, hypothermie)
 - Endocrinologique – Métabolique (électrolytes, reins-foie, glc, thyroïde)
 - ! Psychogène
 - fonctionnel (mal de dos)
- 5) Anamnèse et Status pr creuser

Refus de soins: CURVES

C : Choose & communicate (choisir pr lui même)

U: Understand (consentement éclairé)

R: Reason (capable de raisonner)

V: Value (décision ok avec son système de valeur)

E: Emergency (risque imminent pour sa survie)

S: Surrogate (représentant thérapeutique/légal/proche à consulter)

Refus de soins: DECISION-making capacity

- **D**éterminer s'il y a besoin d'établir la capacité de discernement
- **E**tablir la capacité à communiquer volontairement
- **C**orriger les facteurs réversibles qui peuvent altérer la capacité de discernement
- **I**vestiguer d'éventuels troubles de l'humeur ou des capacités intellectuelles
- **S**onder les buts, valeurs et peurs du patient
- **I**ntégrer les informations pour déterminer la compréhension des alternatives et de leurs conséquences
- **O**uvertement informer le patient et ses proches des résultats de votre évaluation
- **N**oter scrupuleusement les éléments relevant de la capacité ou l'incapacité de discernement dans le dossier médical